

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

CUESTIONARIO STOP-BANG (CRIBADO DE APNEA DEL SUEÑO)

STOP-Bang Questionnaire (Chung et al., 2008, 2012) · Adaptación Oficial en Español (University Health Network, Toronto)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Cuestionario STOP-Bang para el Cribado del Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño
Sigla / Acrónimo	STOP-Bang
Autoría original	Frances Chung et al. (Department of Anesthesiology, University Health Network, Univ. of Toronto, 2008)
Adaptación en español	Versión oficial autorizada por UHN; validada en España (Chung et al., Br J Anaesth 2012)
Constructo evaluado	Riesgo clínico y antropométrico de Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)
Población diana	Adultos en evaluación preanestésica preoperatoria, atención primaria, neumología, cardiología y psiquiatría
Tiempo de aplicación	1 a 2 minutos (autoadministrado o administrado por personal sanitario)
Estructura y formato	8 ítems dicotómicos (Sí / No): 4 síntomas subjetivos (STOP) y 4 factores antropométricos/médicos (BANG)
Condiciones de uso	Propiedad de UHN (www.stopbang.ca); libre para uso clínico y asistencial no comercial

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) es una enfermedad altamente prevalente (afecta al 15 – 30% de los varones y al 10 – 15% de las mujeres adultas) que cursa con colapsos repetidos de la vía aérea superior durante el sueño. Esto origina desaturaciones arteriales recurrentes de oxígeno, activaciones adrenérgicas y fragmentación del sueño, multiplicando el riesgo cardiovascular (hipertensión refractaria, ictus, arritmias) y la morbilidad postanestésica.

Dado que más del 80% de los casos de SAHOS moderado a severo permanecen sin diagnosticar en la comunidad, Frances Chung y su equipo desarrollaron el cuestionario STOP-Bang como una regla de predicción clínica ultra-rápida. Su acrónimo integra cuatro síntomas clínicos cardinales (**S***noring, **T***iredness, **O***bserved apnea, **h**igh blood **P***ressure) con cuatro determinantes fenotípicos de susceptibilidad anatómica (**B***MI, **A***ge, **N***eck circumference, **G***ender).

3. ESTRUCTURA Y CRITERIOS OPERATIVOS DEL STOP-BANG

Ítem	Criterio Clínico	Respuesta	Definición y Umbral Operativo
S	Snoring (Ronquido)	Sí = 1 / No = 0	¿Ronca fuerte? (Tan fuerte que se escucha a través de puertas cerradas)
T	Tired (Cansancio)	Sí = 1 / No = 0	¿Se siente frecuentemente cansado, fatigado o somnoliento de día?
O	Observed (Apneas)	Sí = 1 / No = 0	¿Alguien ha observado que deja de respirar o se ahoga mientras duerme?
P	Pressure (Presión)	Sí = 1 / No = 0	¿Tiene o está recibiendo tratamiento farmacológico para hipertensión arterial?
B	BMI (IMC)	Sí = 1 / No = 0	Índice de Masa Corporal mayor a 35 kg/m²
A	Age (Edad)	Sí = 1 / No = 0	Edad superior a 50 años
N	Neck (Cuello)	Sí = 1 / No = 0	Perímetro del cuello: Varones > 43 cm (17 in); Mujeres > 41 cm (16 in)
G	Gender (Género)	Sí = 1 / No = 0	Sexo biológico masculino

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN CIRUGÍA Y SUEÑO

Sensibilidad para SAHOS leve	Para IAH ≥ 5 eventos/h, sensibilidad del 84% con puntuación ≥ 3 (VPN 70 – 75%).
Sensibilidad para SAHOS moderado	Para IAH ≥ 15 eventos/h, sensibilidad del 93% con puntuación ≥ 3 (VPN 85 – 90%).
Sensibilidad para SAHOS severo	Para IAH ≥ 30 eventos/h, sensibilidad del 96 – 100% con puntuación ≥ 3 (VPN > 95%).
Especificidad diagnóstica	La especificidad para corte ≥ 3 es moderada (40 – 50%), pero se incrementa a 79 – 85% al exigir puntuación ≥ 5 o combinación con factores de riesgo.
Rendimiento preoperatorio	Predice de forma independiente eventos adversos respiratorios postanestésicos (intubación difícil, laringoespasma, desaturación prolongada en URPA; OR = 2.8 – 3.4).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Codificación lineal	Cada respuesta afirmativa (“Sí”) suma 1 punto. Cada “No” suma 0 puntos. Rango total: 0 a 8 puntos .
Medición precisa del cuello	La circunferencia cervical debe medirse con cinta métrica a nivel de la membrana cricotiroides. En mujeres, el umbral de positividad es > 41 cm; en varones, > 43 cm.
Cálculo del IMC	Se calcula como $\frac{\text{Peso (kg)}}{(\text{Altura (m)})^2}$. Positivo si IMC > 35 kg/m ² .
Algoritmo de 2 pasos	Si STOP-Bang está entre 3 y 4 puntos, evaluar si cumple subcriterios específicos de alta especificidad (STOP ≥ 2 más varón, o STOP ≥ 2 más IMC > 35, o STOP ≥ 2 más cuello grande).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación	Prevalencia SAHOS	Estrato de Riesgo	Implicación Clínica y Vía de Manejo
0 - 2	< 15%	Bajo Riesgo de SAHOS	Procedimiento anestésico habitual. Muy baja probabilidad de SAHOS moderado/severo.
3 - 4	35 - 55%	Riesgo Intermedio	Evaluar si cumple criterios combinados de alto riesgo. Precaución con opiáceos.
5 - 8	> 75%	Alto Riesgo de SAHOS	Alta probabilidad de SAHOS severo (IAH ≥ 30). Protocolo de vía aérea difícil y PSG.

CRITERIOS ALTERNATIVOS DE ALTO RIESGO PARA PUNTAJES 3 Y 4:

Un paciente con puntuación STOP-Bang de 3 o 4 se reclasifica como **Alto Riesgo** si presenta:

- 1) Puntuación en STOP ≥ 2 y es Varón; O BIEN
- 2) Puntuación en STOP ≥ 2 e IMC > 35 kg/m²; O BIEN
- 3) Puntuación en STOP ≥ 2 y circunferencia del cuello > 43 cm (varón) o > 41 cm (mujer).

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA PERIOPERATORIA Y EXTRAHOSPITALARIA

Paso 1: Aplicación en Consulta Preanestésica o Atención Primaria: Medir cuello, IMC y tensión arterial; aplicar los 8 ítems.

Paso 2: Si Puntuación 0 — 2 (Bajo Riesgo): Manejo anestésico estándar; no se requiere estudio de sueño preoperatorio.

Paso 3: Si Puntuación 3 — 4 (Riesgo Intermedio): Aplicar criterios combinados. Si no cumple criterios de reclasificación, mantener monitorización estándar de oximetría.

Paso 4: Si Puntuación 5 — 8 (Alto Riesgo) o reclasificado:

- En cirugía programada no urgente diferible: Derivación prioritaria a Unidad de Sueño para poligrafía respiratoria y titulación de CPAP.
- En cirugía no diferible: Planificar manejo de vía aérea difícil, inducción con videolaringoscopia, evitar sobredosis de bloqueantes neuromusculares y analgésicos opioides sistémicos (priorizar anestesia regional/locorregional) y vigilancia en URPA prolongada.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO PREQUIRÚRGICO

Identificación: Paciente varón de 57 años programado para colecistectomía laparoscópica. Antecedentes de hipertensión arterial tratada con enalapril.

Evaluación STOP-Bang: Total = 6 / 8 (Alto Riesgo de SAHOS).

- STOP: Ronquido audible a distancia (Sí = 1); Cansancio diurno (Sí = 1); Apneas presenciadas por cónyuge (Sí = 1); Hipertensión (Sí = 1). Suma STOP = 4.
- BANG: IMC = 36.2 kg/m² (Sí = 1); Edad = 57 años (Sí = 1); Cuello = 44.5 cm (Sí = 1); Género masculino (Sí = 1).

Manejo Perioperatorio: Dado el alto riesgo, se preparó carro de vía aérea difícil con videolaringoscopia, se practicó preoxigenación estricta en posición de Trendelenburg invertido a 30°, analgesia multimodal ahorradora de opiáceos (bloqueo TAP ecoguiado y paracetamol/dexketoprofeno) y monitorización con capnografía continua.

Evolución Postoperatoria: Sin incidentes en extubación; traslado a sala tras 4 horas de saturación estable en URPA. Al alta hospitalaria fue derivado a Neumología, confirmando un IAH de 38 eventos/h e iniciando CPAP domiciliaria con éxito.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgos Quirúrgicos:

- **Vía Aérea Difícil:** Puntuaciones STOP-Bang ≥ 5 triplican el riesgo de ventilación difícil con mascarilla e intubación compleja.
- **Depresión Respiratoria Postoperatoria:** Alta sensibilidad a benzodiacepinas y opioides sistémicos; riesgo crítico de hipoventilación nocturna en camas de hospitalización convencional.

Diagnóstico Diferencial:

- **Herramienta de Cribado, No Diagnóstica:** Un resultado positivo en STOP-Bang no sustituye a la polisomnografía diagnóstica (PSG).
- **Roncopatía Simple:** Ronquido crónico sin apneas ni hipoxemia nocturna ni desestructuración de la arquitectura del sueño.
- **Síndrome de Resistencia de Vía Aérea:** Microdespertares con IAH normal.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Chung, F., Yegneswaran, B., Liao, P., Chung, S. A., Vairavanathan, S., Islam, S., Khajehdehi, A., & Shapiro, C. M. (2008). STOP questionnaire: A tool to screen patients for obstructive sleep apnea. *Anesthesiology*, 108(5), 812-821. <https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e31816d83e4>
- Chung, F., Subramanyam, R., Liao, P., Sasaki, E., Shapiro, C., & Sun, Y. (2012). High STOP-Bang score indicates a high probability of obstructive sleep apnoea. *British Journal of Anaesthesia*, 108(5), 768-775. <https://doi.org/10.1093/bja/aes022>
- Chung, F., Abdullah, H. R., & Liao, P. (2016). STOP-Bang questionnaire: A practical approach to screen for obstructive sleep apnea. *Chest*, 149(3), 631-638. <https://doi.org/10.1378/chest.15-0903>
- Nagappa, M., Liao, P., Wong, J., Patra, J., Chung, F., et al. (2015). Validation of the STOP-Bang questionnaire as a screening tool for obstructive sleep apnea among different populations: A systematic review and meta-analysis. *PLoS ONE*, 10(12), e0143697.